



Ministerio Público de la Defensa
Defensoría General de la Nación

**INICIA ACCIÓN A LOS FINES DE OBTENER UNA RESOLUCIÓN
JUDICIAL EN LOS TÉRMINOS DEL ART. 67 DE LA LEY 27.447**

Sr. Juez:

Gustavo Javier DIP, DNI N° 23.360.410, con domicilio real en la calle Río Ewan Nro. 2724 de esta ciudad, y **Carlos Daniel ROMERO, DNI N° 16.178.394**, con domicilio real en la calle Los Teros Nro. 53, Lomas del Rey, Punilla, provincia de Córdoba, ambos por derecho propio, con el patrocinio letrado del Dr. José G. Bongiovanni, Defensor Público Federal ante el juzgado Federal de Ushuaia, Pcia. de Tierra del Fuego, A. e I. A.S., con domicilio electrónico en DE 20-31473030-6, y constituido en la Av. Maipú 727, piso 1ro. de esta ciudad, nos presentamos a V.S. y decimos:

I.- OBJETO:

Que venimos por la presente en tiempo y forma a iniciar acción sumarísima, en los términos del art. 67 de la ley 27.447, con el fin de que V.S. autorice la intervención quirúrgica, consistente en la ablación de un órgano (riñón), de un donante vivo, el dicente Gustavo Javier Dip, en el carácter de dador y amigo personal del Sr. Carlos Daniel Romero, para su ulterior implante en su cuerpo, en el carácter de receptor; en base a las consideraciones de hecho y derecho que a continuación se expresarán:

II.- HECHOS:

El Receptor, Carlos Daniel –oriundo de esta ciudad-, padece de enfermedad cardiorrenal hipertensiva con insuficiencia

USO OFICIAL

renal, por lo que debió trasladarse a un centro médico de mayor complejidad en la ciudad de Córdoba, donde pudiera ser atendido de manera adecuada.

Fue así que, por medio de su obra social PAMI, se le otorgó la cobertura médico asistencial en la ciudad capital de la provincia de Córdoba, motivo por el cual se vio en la necesidad de mudar su lugar de residencia, al menos, hasta que pudiera mejorar su cuadro clínico, y así, eventualmente poder regresar a su ciudad de origen.

Cabe aquí, realizar una breve pero concreta descripción de su dolencia, y que surge de su epicrisis (cuya copia se acompaña).

Romero, Carlos Daniel, es un paciente de 59 años, con antecedentes de HTA diagnosticada a los 45 años, con un mal manejo, presentó un IAM en el año 2005 con colocación de Stent (atc a DA), con dislipemia severa, en seguimiento por nefrología desde el año 2012, donde se detecta deterioro de la función renal e HPB, en el año 2016 tuvo un muy mal control de su HTA, con un mayor deterioro de la función renal, en el 2019 se le detecta litiasis renal, por lo que empieza con tratamiento con urología. Desde ese año presenta proteinuria grado nefrótico y clearance de creatinina de 20 ml/min., con un mal control de su hipertensión arterial, incumplimiento de dieta, tratamientos propuestos y controles.

Así las cosas, en el mes de septiembre de 2019 el paciente presentó urgencia urológica por litiasis que requirió colocación de pig tail. Desde dicha fecha persiste importante deterioro de la función renal con elevación de productos nitrogenados. En el año 2020, presentó astenia, hiperoxia, pérdida de peso progresivas hasta que el 31/10/20, debido a franca sintomatología urémica, en paciente sintomático y con perfil bioquímico de ERC estadio avanzado se decide su ingreso a tratamiento sustitutivo renal, hemodiálisis, a través de catéter doble lumen subclavio derecho.

Posteriormente, mejora y queda en hemodiálisis ambulatoria trisemanal en servicio de nefrología y hemodiálisis de Ushuaia, desde noviembre de 2020.



Ministerio Público de la Defensa Defensoría General de la Nación

El Sr. Romero, presentó varios procedimientos urológicos por catéter Puig tail calcificado, correcciones de medicación antihipertensiva por mal control de TA. En el mes de mayo de 2021, presentó peilo TAC con riñones disminuidos de tamaño y sin litiasis. Desde el mes de agosto de 2021 presenta Sd de túnel carpiano.

Del detalle de su HC supra descripta, surge que lamentablemente la enfermedad fue progresando de tal manera, que en octubre de 2020, tuvo que comenzar con el tratamiento de hemodiálisis. Fue así, que los médicos tratantes en la clínica donde se está atendiendo en la ciudad de Córdoba, iniciaron los trámites pertinentes para su inscripción en el INCUCAI, realizándose todos los estudios y controles médicos que exige el protocolo de inscripción.

Fue así, que con fecha 27/06/22, habiendo concluido todos los estudios y exámenes médicos de la evaluación pretrasplante órgano/tejidos requeridos, y como resultado de dicha evaluación, el médico tratante, Dr. Jorge Luis De la Fuente, del Hospital Privado de Córdoba, ha considerado al Sr. Carlos Daniel Romero, **APTO PARA TRASPLANTE.**

Por ello, el PAMI –como financiador-, ha dado la autorización para el trasplante; y el organismo jurisdiccional ECODIAC, responsable de la inscripción, tomó la intervención en la fiscalización de los procesos administrativos y certificó que se han cumplido todos los requisitos médicos y legales.

En consecuencia, se ha concluido con el proceso de inscripción Nro. 439537, incorporándose a la lista de espera para trasplante RENAL, de conformidad con el Sistema Nacional de Información de Procuración y Trasplante, y conocimiento del INCUCAI.

Asimismo, cabe decir que el dicente he realizado una prueba cruzada por citometría de flujo con el potencial receptor Carlos Daniel Romero, cuyo resultado demostró compatibilidad inmunológica para permitir la donación de un riñón con fines de trasplante.

Por otro lado, se debe agregar que el Sr. Romero no tiene parientes cercanos que puedan ser compatibles como donantes.

A un mayor abundamiento, es preciso señalar que el tratamiento de diálisis le ha restado al paciente independencia en su vida diaria, y le generó la necesidad de descansar más tiempo después de cada cesión.

Además, le limitó su movilidad dentro y fuera de la provincia, porque debe buscar un centro de diálisis adonde vaya, y que su obra social pueda cubrirlo.

Nótese, que con el transcurso del tiempo, su cuerpo sufre el deterioro propio del tratamiento de diálisis, como ser: pérdida de masa muscular, deterioro óseo, mal funcionamiento de glándulas hormonales como suprarrenales y paratiroides.

Ante tal situación, y la posibilidad de recibir un riñón cadavérico que resulta incierta e incompatible con la urgencia de la patología que padece, es que movido por un profundo sentimiento de amistad, solidaridad, humanidad y altruismo, es que he decidido donarle un riñón a Carlos Daniel Romero tras las imposibilidades supra descriptas respecto a sus parientes más próximos.

Que se torna de suma urgencia realizar cuanto antes un trasplante renal, ya que podría tener una expectativa de vida concreta y real, mejor calidad vida, recuperar gran parte de su independencia, teniendo una vida normal.

Así pues, ante la especial situación en la que vive el Sr. Romero, es que como su amigo a quién conozco desde que se vino a vivir a esta ciudad en el año 1993, y con el cual mantengo un profundo lazo de amistad, le he manifestado que deseo donarle un riñón.

He decidido donarle un riñón por un acto de amor, solidaridad y amistad profunda con Carlos Daniel, manifestación adoptada



Ministerio Público de la Defensa
Defensoría General de la Nación

con discernimiento, intención y libertad, no verificándose ningún indicio de inducción o coacción, y con el debido consentimiento informado.

Asimismo, manifiesto que no he recibido ni recibiré beneficio económico alguno por la donación que pretenda hacer, y que conozco y comprendo las eventuales consecuencias médico-clínicas que podría padecer en un futuro por quedarme sin un riñón.

Por lo expuesto, es que solicito a V.S. que haga lugar al pedido aquí articulado, ordenando se autorice la realización de la praxis médica pertinente.

III.- DERECHO:

Se funda el derecho que asiste a los aquí peticionantes, en las disposiciones de la ley 27.447, y en la unánime y pacífica jurisprudencia aplicable al caso.

En primer lugar, cabe decir que el implante de órganos, tejidos y células debe ser realizado cuando los otros medios y recursos disponibles se hayan agotado, sean insuficientes o inconvenientes o resulte la mejor alternativa terapéutica para la salud del paciente, conforme a la evidencia científica (cfr. art. 2º, inc. 2, de la ley 27.447).

A ello, y como un mandato de optimización al que el órgano jurisdiccional debería ceñirse, cabe mencionar que a la hora de decidir el Sr. Juez no podrá soslayar entre los principios en los que se enmarca la ley aplicable.

De ellos, resulta dable destacar: **1. Respeto por la dignidad humana en todas sus dimensiones. 2. Respeto por la autonomía de la voluntad como fundamento ético y legal de toda intervención médica. 8.-La autosuficiencia, entendida como el desarrollo de políticas y estrategias que permitan maximizar la disponibilidad de órganos, tejidos y células, a fin de garantizar la disminución progresiva en las listas de espera. 9. Voluntariedad, altruismo y gratuidad en la donación.**

Así, resulta menester mencionar que se ha sostenido que el art. 22 de la ley 27.447 establece que: *“solo estará permitida la ablación de órganos y tejidos en vida con fines de trasplante sobre una persona capaz mayor de dieciocho (18) años, quien puede autorizarla únicamente en caso de que el receptor sea su pariente consanguíneo o por adopción hasta el cuarto grado, o su cónyuge, o una persona con quien mantiene una unión convivencial, conforme la normativa vigente...”*.

Es así, como delimitar los casos, condicionándolos a ciertas relaciones entre el dador y el receptor del órgano, para luego continuar regulando que, en todos esos casos, será indispensable el dictamen favorable del equipo médico a que se refiere el art. 5°, es decir, emitido por un médico registrado y habilitado al efecto por ante la respectiva autoridad de contralor jurisdiccional.

Entendemos que el tipo de autoridad “jurisdiccional” a la que se refiere es aquella que controla y es responsable de la inscripción de personas en la esfera administrativa.

Tenemos para nosotros en forma clara, que cuando el art. 22 prevé que sólo estará permitida la ablación con fines de trasplante en los casos que taxativamente menciona (también utiliza la expresión “únicamente” cuando se refiere a la autorización), lo hace refiriéndose a aquellos casos en que el contralor y el procedimiento están a cargo, y se realiza, por ante la autoridad jurisdiccional administrativa.

Que dentro de este contexto, es necesario recurrir a los criterios de la interpretación sistemática que permitan desentrañar la finalidad de la ley en su integridad, reconociendo vigencia a ambas normas, al art. 22, 23 y al art. 67 de la ley de trasplantes.

En este sentido, cuando no se dan aquellas condiciones que la ley reserva su control y el procedimiento por ante el órgano y sede administrativa (cfr. art 5, 9, 22, 23 y cc), debe recurrirse a la acción judicial civil (cfr. art. 67 y cc), tendiente a obtener una resolución de



Ministerio Público de la Defensa Defensoría General de la Nación

las cuestiones extrapatrimoniales relativas a la ablación e implantes de órganos o tejidos a través del procedimiento especial fijado.

Es así, como la intervención de los peritos judiciales tiene como objetivo corroborar aquellos aspectos anatómicos y los psicológicos referentes al conocimiento que pudieran tener los interesados de las secuelas, riesgos, posibilidades de éxito, derecho a retractación del dador antes de la ablación, etc.

La audiencia, en sede judicial viene así a dar con los recaudos que en sede administrativa deben ser cumplidos por los jefes y subjefes de los equipos, y por los profesionales a los que se refiere el art. 5° (art. 9 y cc.).

Por otro lado, la intervención de los magistrados del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa (este último, en caso de menores), cumple el rol que en la esfera administrativa tiene la autoridad de control en aquella jurisdicción.

De esta forma se entiende la utilidad, y la presencia de los sujetos que deben velar por el cumplimiento de los recaudos legales; en sede administrativa sólo en los casos previstos por el arts. 22, 23 y en sede judicial cuando sin serlo de éstos, se busque obtener una resolución respecto de cuestiones extrapatrimoniales relativas a la ablación e implante de órganos.

Al respecto se ha dicho:

“...en el proceso de interpretación judicial de normas, conductas jurídicas y sus consiguientes valoraciones, el juez elige la solución y para ello analiza las consecuencias naturales que de ella derivan, (particulares y sociales), y aplica lo que es verdaderamente útil mediante el conocimiento de lo necesario y de lo contingente con referencia al caso concreto”.

“Si no se recurre a tal criterio de interpretación, la admisión de soluciones disvaliosas (pérdida de la vida, incapacidad

permanente, etc.), no sería compatible con el fin común de la tarea legislativa y judicial; las consecuencias derivadas como naturales constituyen uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad, la interpretación y su congruencia con el sistema en que está inserta la norma. Paralelamente, el juez debe verificar también la congruencia de esta interpretación con el sistema legal en que está alojada la norma; pero ya no se trata solamente que las normas generales sean justas, también debe serlo su aplicación a los casos concretos”.

“De lo contrario, esas soluciones por injustas y disvaliosas, son inconstitucionales, porque riñen con el afianzamiento de la justicia, que es un principio operativo de la Constitución” (cfr. Nóbili, Alejandro, “Trasplante entre personas no emparentadas” y sus citas, en la Ley 2004-A-1216).

Cabe concluir entonces, que fuera de los casos previstos en el art. 22 y 23 (sujeto a la jurisdicción administrativa), el pedido de autorización de una ablación e implantación de órganos entre sujetos vivos debe ser tratada en sede judicial si se cumplen los requisitos establecidos en la ley. Y este es uno de esos particulares casos (cfr. asimismo, Juzg. Civ. y Com. Fed. N° 5, Sec. 10, de la CABA, en autos: “Mianovich, Sandra s/ sumarísimo –ley 24.193–”, Expte. N° 3496/12).

Finalmente, y aun mayor abundamiento sobre la cuestión, no se puede soslayar un fallo de la Excma. Cámara en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal, donde se dijo que:

“...más allá de la cantidad de días, lo más grave es que en este caso el tiempo marcó la diferencia entre la posibilidad de sobrevivida o la muerte inevitable de un niño de 9 años. Cuatro cuerpos; 670 fojas; este es el tamaño que tiene la historia clínica de este niño que murió porque se demoraron 90 días en dar la autorización para un trasplante. Para decirlo con toda claridad, este ser humano murió por la falta de actuación oportuna de los organismos del Estado responsables de su salud. Ha dicho la Corte en reiteradas oportunidades que el derecho a la vida -que incluye a la salud- es el primer derecho de la persona garantizado por la



Ministerio Público de la Defensa
Defensoría General de la Nación

Constitución Nacional y por tratados internacionales, y constituye un valor fundamental respecto del cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental (Fallos 323:3229 y 324:3569) (cfr. CNCCFed., Sala III, causa N° 8.553/04, “TAPIA JUAN DOMINGO Y OTRO C/ MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION s/ daños y perjuicios”. Del 11/07/13, (votos Dra. Graciela Medina - Dr. Ricardo Gustavo).

IV.- SE FIJE AUDIENCIA:

A los fines de lo dispuesto por el art. 67, inc. b) y c) y d), de la ley 27.447, solicito a V.S. que fije audiencia en un plazo no mayor a tres días (cfr. inc. b) de la ley).

V.- PLANTEA INCONSTITUCIONALIDAD:

Para el hipotético y remoto caso que V.S. entienda que el art. 22 de la ley 27.447 no posibilita la ablación e implante de órganos o materiales anatómicos entre personas vivas que no reconozcan entre si parentesco y/o vínculo familiar alguno, es que se deja planteada – subsidiariamente-, la tacha de inconstitucionalidad de la citada cláusula legal.

VI.- COMPETENCIA:

Que de conformidad con lo dispuesto por el art. 67 de la ley 27.447, V.S. resulta competente para entender en la presente acción civil tendiente a obtener una resolución judicial respecto de una cuestión extrapatrimonial relativa a la ablación e implante de órganos o tejidos.

Así lo tiene decidido la jurisprudencia más entendida en la materia. En este sentido, se dijo que:

“El art. 56 de la ley 24.193 establece que toda acción civil tendiente a obtener una resolución judicial respecto de cuestiones extrapatrimoniales relativas a la ablación e implante de órganos o materiales anatómicos, será de competencia de los tribunales federales

en lo civil del domicilio del actor. En consecuencia, es claro -teniendo en cuenta el domicilio de las actoras- que de acuerdo con la norma citada, resulta competente para entender en el sub lite la Justicia en lo Civil y Comercial Federal (cfr. CNCCFed., Sala III, causa N° 7.724/09, “SPINELLI JULIA MONICA y otro s/ sumarísimo ley 24.193”, del 6/10/09, votos del Dr. Ricardo Gustavo Recondo y de la Dra. Graciela Medina).

Asimismo, que:

“El art. 56 de la ley 24.193 establece que toda acción civil tendiente a obtener una resolución judicial respecto de cuestiones extrapatrimoniales relativas a la ablación e implante de órganos o materiales anatómicos, será de competencia de los tribunales federales o provinciales en lo civil del domicilio del actor (conf. Ésta Cámara, Sala III, causa 7724/09 del 6.10.09). En consecuencia, teniendo en cuenta el domicilio del actor, no existe mérito para apartarse de la decisión adoptada por el magistrado de la anterior instancia (cfr. CNCCFed, Sala I, causa N° 3.752/14, “O. R. S/ SUMARISIMO LEY 24.193”, del 26/08/14, votos del Dr. Ricardo Víctor Guarinoni y de la Dra. María Susana Najurieta).

Resulta claro, que la norma establece la posibilidad de entablar la demanda ante la justicia federal y/o provincial en lo civil del domicilio del actor.

En consecuencia, toda vez que el donante se domicilia en esta ciudad, y que es voluntad de ambos, dador y receptor, ocurrir ante la justicia federal con asiento en esta Provincia, solicito que V.S. se declare competente para entender en las presentes actuaciones

VII.- GRATUIDAD DEL TRÁMITE:

En virtud de lo establecido por el art. 67, inc. k) de la ley 27.447, la presente petición se encuentra exenta del pago de los sellados, tasas, impuestos o derechos de cualquier naturaleza, lo que así solicito a V.S. se provea.

VIII.- PRUEBAS:



Ministerio Público de la Defensa
Defensoría General de la Nación

A fin de acreditar los hechos mencionados en el presente, se ofrece la siguiente prueba:

a) DOCUMENTAL:

1) Constancia de inscripción en la lista de espera de fecha 28/02/23.

2) Estudio del donante Crossmatch vs. Donante por citometría de flujo del Hospital Privado, Laboratorio de Histocompatibilidad y Biología Molecular, de fecha 18/01/23.

3) Informe del médico tratante Dr. Jorge Luis De la Fuente, Médico Nefrólogo, Jefe del Programa de Trasplantes.

4) Informe médico del Dr. Edmundo Videla, coordinador médico de Fesenius Medical Care, de fecha 27/02/23.

5) copias de los DNI del donante y del receptor.

6) Copia del carnet de afiliado al PAMI del Sr. Romero.

7) Acta de información sanitaria y consentimiento informado del Sr. Gustavo Javier Dip de fecha 08/03/23.

8) Copia del Acta celebrada en la sede de la DPO dando cuenta de la entrevista mantenida con el Sr. Gustavo Javier Dip con el Dr. José G. Bongiovanni y con el Dr. Matías Agustín Ciolfi.

PETITORIO:

1) Se me tenga presentadas en el carácter invocado, por denunciado el domicilio real y constituido el procesal y el domicilio

USO OFICIAL

electrónico en el domicilio de nuestro letrado patrocinante, Dr. José G. Bongiovanni.

2) Se tenga presente la prueba ofrecida y se agregue la acompañada. -

3) Se tenga presente lo manifestado respecto a la competencia, solicitando a V.S. que entienda en las presentes actuaciones, evitando dilaciones innecesarias con conflictos de competencia, teniendo en cuenta la urgencia y gravedad que el caso amerita.

4) Se imprima a las presentes el trámite previsto en el art. 67, primera parte de la ley 27.447.

5) Se fije audiencia dentro de los tres días, de conformidad con lo establecido por el art. 67, inc. b, c y d, de la ley 27.447.

6) Se tenga presente la gratuidad del trámite, Y así se declare.

7) Oportunamente, V.S. dicte sentencia en los términos del art. 67 de la ley 27.447, otorgando la autorización judicial para que el equipo de nefrología del Hospital Privado de Córdoba practique el trasplante de riñón del donante Sr. Gustavo Javier Dip al receptor aquí coaccionante, Carlos Daniel Romero.

Proveer de conformidad, que

SERÁ JUSTICIA. -

Carlos Daniel Romero

Gustavo Javier Dip
DNI 23360410

JOSE BONGIOVANNI
Defensor Público Oficial

Signature Not Verified

Digitally signed by JOSE GABRIEL
BONGIOVANNI SERVERA
Date: 2023.04.03 12:36:10 ART

Escaneado con CamScanner